



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

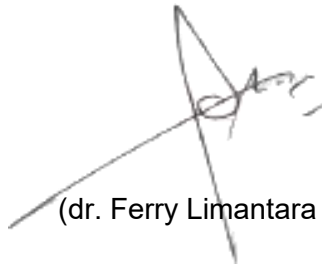
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan
Telp. 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Instalasi
Gawat Darurat Tahun 2025

Disusun oleh:
Kepala Instalasi Gawat Darurat



(dr. Ferry Limantara Sp.EM)

Disetujui Oleh :
Autorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah , M.Kes. AFP

PENYUSUN

1. dr. Ferry Limantara ., Sp.EM
2. dr. Achmad Fauzan Ailani
3. dr. Tania Calista
4. dr. Nejoa Ermaq Fatreciano
5. dr. Wahyu Firmansyah
6. dr. Moch. Dicky Wahyu Irawan
7. dr. Nurdiana Rahmadani
8. dr. Ahmad Ridho Mustawa
9. dr. Yuriansyah Dwi Rahmaputra
10. dr. Moch. Choiruz Zaman
11. Aini Nur Rokhma., Amd.Kep
12. Nurul Karima., Amd.Kep
13. Ns. Liliani Permata Sari., S.Kep
14. Ns. Sri Rahayu Kurniawati., S.Kep
15. Ns. Siti Rahmawati., S.Tr.Kep
16. Ns. Lilis Ernawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya Pedoman Instalasi Gawat Darurat dan Kesiambungan Pelayanan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Instalasi Gawat Darurat yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Instalasi Gawat Darurat ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 9 Januari 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HUSADA
NOMOR : 036.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 545/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Subsector Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
6. Kepdirjen Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrument Survei Akreditasi Rumah Sakit
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standar akreditasi rumah sakit
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43853/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit Kelas D Pratama
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
10. Kepkonsil No. 21A Th 2006 ttg Pengesahan Standar Kompetensi Dokter
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (01 November 2025 hingga 31 Oktober 2026)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT
DARURAT (IGD)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam organisasi dan manajemen di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

BAB II SKRINING

Pasal 2

- (1) Skrining penerimaan pasien dilaksanakan melalui jalur cepat (*fast track*) kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisik, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging sebelumnya.
- (2) Skrining di dalam maupun luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan / spesifik untuk menetapkan pasien diterima atau dirujuk;
- (3) Pelaksanaan proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- (4) Skrining dilakukan untuk menilai apakah rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pasien serta konsisten dengan misi rumah sakit;
- (5) Pada pelaksanaan skrining, dapat ditentukan tes atau bentuk penyaringan terhadap populasi pasien tertentu sebelum menetapkan pasien dapat dilayani dengan menghubungi nomor IGD Rumah Sakit 08113789016 dan mencatat komunikasi skrining di buku baik dari faskes atau dari rumah
- (6) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dibutuhkan pasien;
- (7) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien;
- (8) Prioritas diberikan pada pelayanan terkait preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif.

BAB III TRIASE

Pasal 3

- (1) Proses triase dan pelayanan kegawatdaruratan diterapkan oleh staf yang kompeten dan bukti dokumen kompetensi dan kewenangan klinisnya tersedia.
- (2) Kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat meliputi triase dan tindakan penyelamatan nyawa (*life saving*);
- (3) Triase merupakan pemeriksaan awal atau skrining secara cepat terhadap semua pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawatdaruratannya dan prioritas penanganan;
- (4) Pasien darurat dinilai dan di stabilkan sesuai kapasitas rumah sakit sebelum di transfer ke ruang rawat atau

- dirujuk dan didokumentasikan dalam rekam medik.
- (5) Implementasi triase di RS Prima Husada Sukorejo disesuaikan dengan Sarana dan Prasarana yang ada. Adapun pembagian triase merupakan kombinasi antara ATS dan PMK No 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

BAB IV PENUNDAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pasien dan atau keluarga diberikan informasi jika ada penundaan dan atau keterlambatan pelayanan beserta alasannya dan dicatat di rekam medis.
- (2) Keterlambatan pada pasien adalah kondisi dimana suatu pelayanan/ tindakan melebihi durasi yang normatif;
- (3) Pasien dan atau keluarga diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai dengan kebutuhan klinis pasien dan di catat dalam rekam medis.

BAB V ALUR PASIEN

Pasal 5

- (1) Alur pendaftaran pasien rawat jalan;
- (2) Alur pendaftaran pasien rawat inap;
- (3) Alur pendaftaran pasien gawat darurat;
- (4) Alur penerimaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap;
- (5) Alur mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun diseluruh rumah sakit;
- (6) Proses pelaksanaan sistem pendaftaran rawat jalan dan rawat inap secara online;
- (7) Pasien gawat darurat tidak ditarik uang muka untuk pelayanan;
- (8) Alur untuk menghindari penumpukan termasuk pada keadaan bencana;
- (9) Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dilaksanakan agar dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien;
- (10) Komponen dari pengelolaan alur pasien meliputi :
 - (a) Ketersediaan tempat tidur rawat inap;
 - (b) Perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
 - (c) Perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;
 - (d) Alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca-anastesi);
 - (e) Pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - (f) Akses pelayanan yang bersifat mendukung (Seperti pekerja sosial, kegamaan atau bantuan spiitual, dan sebagainya).

BAB VI HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN ASUHAN

Pasal 6

- (1) Rumah sakit menetapkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga;
- (2) Pasien memiliki hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan pada keluarga atau pihak lain;
- (3) Semua staff memperoleh edukasi dan memahami tentang hak serta kewajiban pasien dan keluarga;
- (4) Staff bertanggung jawab melindungi hak pasien.

Pasal 7

- (1) Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agama dan memahami agama, keyakinan, nilai-nilai pribadi pasien, serta menghormati dan menerapkan dalam asuhan pasien yang diberikan;
- (2) Rumah sakit menanggapi permintaan rutin termasuk permintaan kompleks terkait dukungan agama dengan memfasilitasi bimbingan keohanian di rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Rumah sakit mengatur tentang kewajiban simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien.
- (2) Pasien diberitahu bahwa segala informasi tentang kesehatan pasien adalah rahasia dan kerahasiaan itu akan dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pasien harus diminta persetujuannya untuk pelepasan informasi medis;
- (4) Staf mampu mengidentifikasi dan menghormati harapan dan kebutuhan privasi saat wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur, pengobatan dan transfer pasien.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus dikarenakan kondisi pasien tertentu yang tidak mampu menjaga barang miliknya saat dirumah sakit;
- (2) Staf mampu menjelaskan tanggung jawabnya dalam menjaga barang milik pasien tersebut kepada pasien.

Pasal 10

Rumah sakit melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan diantaranya ruang bayi, kamar operasi dan kasir (pembayaran).

Pasal 11

- (1) Pasien dan keluarga ikut berpartisipasi dalam proses asuhan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya;
- (2) Staf dilatih dan terlatih melaksanakan perannya dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Pasal 12

- (1) Pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang

kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga.

- (2) Pasien diberi informasi tentang kondisi medis mereka dan diagnosis pasti;
- (3) Pasien diberi informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- (4) Pasien dijelaskan bila ada tindakan yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan menjelaskan proses memberikan persetujuan;
- (5) Pasien dijelaskan hasil yang diharapkan maupun kemungkinan hasil tidak terduga dari proses asuhan dan pengobatan;
- (6) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan.

Pasal 13

- (1) Rumah sakit mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA.
- (2) Pasien dijelaskan diagnosis, kondisi pasien, tindakan yang diusulkan, tata cara dan tujuan tindakan, manfaat dan resiko tindakan, DPJP pelaksana tindakan, kemungkinan alternatif dari tindakan, prognosis, kemungkinan hasil yang tidak terduga serta kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan;
- (3) DPJP, PPJA, dan PPA harus memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu pasien.

Pasal 14

- (1) Pasien serta keluarganya berhak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.
- (2) Pasien dan keluarga dijelaskan konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan harus bertanggung jawab terkait dengan keputusan tersebut;
- (3) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

Pasal 15

Rumah sakit menetapkan peraturan pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma, agama, dan budaya masyarakat.

BAB VII TRANSFER INTRAHOSPITAL

Pasal 16

- (1) Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien.
- (2) Form tersebut memuat indikasi pasien masuk dirawat;
- (3) Form tersebut memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostic;
- (4) Form tersebut memuat setiap diagnosis yang dibuat;
- (5) Form tersebut memuat setiap prosedur yang dilakukan;
- (6) Form tersebut memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan;

- (7) Form tersebut memuat keadaan pasien pada waktu dipindah (transfer).
- (8) Ketentuan tersebut dilaksanakan.

BAB VIII RUJUKAN

Pasal 17

- (1) Rujukan dilaksanakan atas persetujuan pasien atau keluarga.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien dan / atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - (a) Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - (b) Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - (c) Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - (d) Transportasi rujukan;
 - (e) Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 18

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan rujukan adalah :

- (1) Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- (2) Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
- (3) Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 19

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Identitas pasien;
- (2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- (3) Diagnosis kerja;
- (4) Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- (5) Tujuan rujukan;
- (6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien.
- (2) Selama proses transportasi rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
- (3) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

Pasal 21

Pasien atau keluarga diberi penjelasan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan dengan memaut

- (1) Penundaan pelayanan;
- (2) Lembar edukasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 sampai pasal 21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 23

Peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 9 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 036.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
GAWAT DARURAT (IGD)

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit menetapkan tentang penerimaan pasien dirawat inap atau pemeriksaan pasien dirawat jalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai dengan misi serta sumber daya rumah sakit yang ada. Menyesuaikan kebutuhan pasien dengan misi dan sumber daya rumah sakit bergantung pada informasi yang didapat tentang kebutuhan pasien dan kondisinya lewat skrining pada kontak pertama.

Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisis, psikologis, laboratorium klinis, *diagnostic imaging* sebelumnya. Skrining dapat terjadi di tempat pasien, ambulance atau waktu pasien tiba di rumah sakit. Keputusan untuk mengobati, mengirim, atau merujuk dibuat setelah ada evaluasi hasil skrining. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanannya maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan.

Pasien yang masuk ke IGD Rumah Sakit Prima Husada tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan *response time* yang cepat dan penanganan yang tepat.

Semua itu dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumberdaya manusia dan manajemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit sesuai dengan standart.

Untuk itu rumah sakit prima husada harus dapat Menyusun perencanaan di bidang Kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat yang baik dan terarah agar mutu pelayanan Kesehatan tidak menurun, sebaliknya meningkat dengan pesat. Oleh karenanya DEPKES perlu membuat standar yang baku dalam pelayanan gawat darurat yang dapat menjadi acuan bagi Rumah Sakit Prima Husada dalam mengembangkan pelayanan gawat darurat khususnya di Instalasi Gawat Darurat RS.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan dengan mutu tinggi serta mengutamakan keselamatan pasien.
2. Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan dapat berjalan dengan baik berdasarkan SPO sehingga keselamatan pasien dapat dimaksimalkan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dengan pengutamaan pada upaya preventif dan kuratif, dan
4. Menciptakan instalasi rawat jalan dengan pelayanan yang nyaman dan lingkungan yang aman.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

1. Setiap rumah sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang memiliki kemampuan :
 - a. Melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat.
 - b. Melakukan resusitasi dan stabilisasi (*living saving*).
2. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit harus dapat memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.

3. Berbagai nama untuk instalasi/unit pelayanan gawat darurat di rumah sakit di seragamkan menjadi Instalasi Gawat Darurat (IGD).
4. Rumah sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat.
5. Pasien gawat darurat harus di tangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.
6. Organisasi Instalasi Gawat Darurat didasarkan pada organisasi multidisplin, multiprofesi dan terintegrasi dengan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat dengan wewenang penuh yang dipimpin oleh dokter.
7. Setiap Rumah Sakit wajib berusaha untuk menyesuaikan pelayanan gawat daruratnya minimal sesuai dengan klasifikasi berikut :
 - a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standart minimal untuk Rumah Sakit Kelas A,
 - b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standart minimal untuk Rumah Sakit Kelas B,
 - c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standart minimal untuk Rumah Sakit Kelas C,
 - d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standart minimal untuk Rumah Sakit Kelas D

1.4 Batasan Operasional

1. Gawat Darurat
Adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
2. Pelayanan Gawat Darurat
Adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/ pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
3. Korban/ Pasien Gawat Darurat
Adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
4. Triase
Adalah pengelompokkan pasien yang berdasarkan atas berat ringannya trauma/penyakit serta kecepatan penanganan/pemindahannya.
5. Prioritas
Adalah penentuan mana yang harus didahulukan mengenai penanganan dan pemindahan yang mengacu tingkat ancaman jiwa yang timbul.
6. Survei Primer
Adalah deteksi cepat dan koreksi segera terhadap kondisi yang mengancam jiwa.
7. Survei Sekunder
Adalah melengkapi survei primer dengan mencari perubahan-perubahan anatomi yang akan berkembang menjadi semakin parah dan memperberat perubahan fungsi vital yang ada berakhir dengan mengancam jiwa bila tidak segera diatasi.
8. Pasien Gawat Darurat
Adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badanya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
9. Pasien Gawat Tidak Darurat
Adalah pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat misalnya kanker stadium lanjut.
10. Pasien Darurat Tidak Gawat
Adalah pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badanya, misalnya luka sayat dangkal.
11. Pasien Tidak Gawat Tidak Darurat
Adalah pasien yang tidak berada dalam keadaan gawat tidak memerlukan tindakan darurat atau tidak mengancam nyawa dan anggota badanya (akan menjadi cacat) misalnya pasien dengan batuk pilek, TBC kulit, dan sebagainya.
12. Kecelakaan (*Accident*)
Adalah suatu kejadian dimana terjadi interaksi berbagai faktor yang datangnya

- mendadak, tidak dikehendaki sehingga menimbulkan cedera fisik, mental dan sosial.
13. Cidera
Adalah masalah kesehatan yang didapat atau dialami sebagai akibat kecelakaan.
 14. Bencana
Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan pertolongan dan bantuan.

1.5 Jenis Pelayanan

Level IV	Level III	Level II	Level 1
Memberikan pelayanan sebagai berikut : 1. Diagnosis dan penanganan : Permasalahan pada A,B,C dengan alat-alat yang lebih lengkap termasuk ventilator 2. Penilaian disability, penggunaan obat EKG, defibrilasi 3. Observasi HCU/R Resusitasi - ICU 4. Bedah cito	Memberikan pelayanan sebagai berikut : 1. Diagnosis dan penanganan : Permasalahan pada A,B,C dengan alat-alat yang lebih lengkap termasuk ventilator 2. Penilaian disability, penggunaan obat, EKG, defibrilasi 3. Observasi HCU/R. 4. Bedah cito	Memberikan pelayanan sebagai berikut : 1. Diagnosis dan penanganan : Permasalahan pada A : Jalan nafas problem (airway problem) B : penafasan (Breathing problem) C : sirkulasi pembuluh darah (circulation problem) 2. Penilaian disability, penggunaan obat, EKG, defibrilasi (observasi HCU) 3. Bedah cito	Memberikan pelayanan sebagai berikut : 1. Diagnosis dan penanganan : Permasalahan pada A : Jalan nafas problem (airway problem) B : penafasan (Breathing problem) C : sirkulasi pembuluh darah (circulation problem) 2. Melakukan stabilisasi dan evakuasi

Rumah Sakit Prima Husada merupakan pelayanan IGD level II.

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi SDM

Sesuai dengan Kemenkes 856 tahun 2009 tentang standar IGD, RS Prima Husada (tipe C) adalah level 2. Pola ketenagaan dan kualifikasi SDM IGD adalah penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, dilaksanakan oleh tenaga medis profesional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan baik dari aspek hukum, strata pendidikan, kualitas maupun kuantitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan pelanggan. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keluasan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi rumah sakit. Dalam menyelenggarakan pelayanan gawat darurat dilakukan oleh profesi dokter dan perawat.

Tenaga profesi dokter dan perawat yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RS Prima Husada memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Kepala instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Prima Husada dipimpin oleh dokter spesialis Emergency
2. Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit prima Husada dipimpin oleh oerawat yang mempunyai pengalaman di bagian IGD, yang telah melalui surat tanda registrasi perawat (STRP), pelatihan kegawat daruratan seperti PPGD, BTCLS, dan BCLS.
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat rumah sakit Prima Husada diselenggarakan dan dikelola oleh dokter umum yang telah memiliki SIP, pelatihan kegawatdaruratan seperti ATLS, ACLS.
4. Pada pelaksanaannya dokter umum dibantu oleh tenaga medis keperawatan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP), PPGD, BTLS, BCLS.

2.2 Distribusi Ketenagaan

Tabel 2.1 Distribusi Ketenagaan

Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
Kepala Instalasi	1 shift	1 orang
Dokter Umum	3 shift	10 orang
Kepala Ruang	1 shift	1 orang
Kepala Tim	3 shift	5 orang
Perawat Pelaksana	3 shift	19 orang
Bidan Pelaksana	3 shift	4 orang

2.3 Pengaturan Jaga

Tabel 2.2 Pengaturan Jaga

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu
1	Kepala Instalasi	1 shift	08.00 – 16.00
2	Dokter Umum	3 shift	07.00 – 14.00 14.00 – 21.00 21.00 – 07.00
3	Kepala Ruang	1 shift	08.00 – 16.00
4	Kepala Tim	3 shift	07.00 – 14.00 14.00 – 21.00 21.00 – 07.00
5	Perawat Pelaksana	3 shift	07.00 – 14.00 14.00 – 21.00 21.00 – 07.00
6	Bidan Pelaksana	3 shift	07.00 – 14.00 14.00 – 21.00 21.00 – 07.00

BAB III
STANDAR FASILITAS

- 3.1 Denah Ruangan
- 3.2 Standar Fasilitas

Tabel 3.1 Standar Fasilitas

Aspek	IGD RS Tipe C	IGD Level 2
Dasar Acuan	Permenkes 856/Menkes/SK/IX/2009, Permenkes 47 Tahun 2018	Permenkes 47 Tahun 2018
Kemampuan Layanan	Kasus umum dan gawat darurat dasar -sedang	Gawat darurat sedang - berat (non spesialisik kompleks)
Ruang Wajib	Triase, resusitasi, tindakan, observasi, ruang tunggu keluarga, toilet, pendaftaran pasien baru/rawat, ruangan kebidanan, ruang dekontaminasi	Triase, resusitasi, tindakan, observasi, ruang tunggu keluarga, toilet, pendaftaran pasien baru/rawat, ruangan kebidanan, ruang dekontaminasi
Peralatan	Defibrilator, oksigen, suction, monitor, alat infus	Defibrilator, monitor, airway set
Penunjang	Laboratorium, radiologi, ambulance	Laboratorium 24 jam, radiologi, ambulans rujukan
SDM	Dokter umum 24 jam, perawat	Dokter terlatih emergency, perawat bersertifikat

- 3.3 Prasarana Medis

Tabel 3.2 Prasarana Medis

No	Jenis Alat	Contoh / Isi	Fungsi
1	Alat resusitasi	Defibrillator, Ambu bag	Mengatasi henti jantung/napas
2	Alat airway (jalan napas)	Laringoskop, ETT, OPA/NPA	Membuka & menjaga jalan napas
3	Alat bantu napas	Ventilator, oksigen set	Membantu pernapasan pasien
4	Monitor pasien	Monitor jantung, SpO ₂ , tensi	Memantau kondisi vital
5	Alat infus	Infus set, infusion pump	Pemberian cairan/obat
6	Alat tindakan	Set jahit luka, minor surgery set	Tindakan medis darurat
7	Alat imobilisasi	Bidai, cervical collar, spine board	Menangani trauma/cedera
8	Alat diagnostik	Stetoskop, tensimeter, termometer	Pemeriksaan awal pasien
9	Alat suction	Mesin suction	Menghisap cairan/lendir
10	Alat emergensi obat	Troli emergensi + obat	Penanganan cepat kasus gawat
11	Alat transport pasien	Brankar, kursi roda	Memindahkan pasien
12	Alat steril & APD	Sarung tangan, masker, steril set	Pencegahan infeksi
13	Alat luka & perdarahan	Kasa, perban, tourniquet	Menghentikan perdarahan
14	Alat akses vaskular	IV catheter, syringe	Akses pembuluh darah

BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Pelayanan IGD RSPHS
Tabel 4.1 Pelayanan IGD RSPHS

Jenis Upaya	Pelayanan yang Bisa Dilakukan di IGD	Pelayanan yang Tidak Bisa Dilakukan di IGD
Promotif	Edukasi singkat (misal: pencegahan cedera, penggunaan obat)	Program penyuluhan kesehatan massal, promosi kesehatan jangka panjang
Preventif	Tindakan pencegahan komplikasi (misal: tetanus toxoid pada luka)	Imunisasi rutin lengkap, skrining kesehatan berkala
Kuratif	Resusitasi, pemberian obat darurat, jahit luka, stabilisasi pasien	Pengobatan penyakit kronis jangka panjang, operasi elektif
Rehabilitatif	Mobilisasi awal sederhana, rujukan rehabilitasi	Fisioterapi jangka panjang, program rehabilitasi terpadu
Paliatif	Penanganan nyeri akut, kenyamanan pasien terminal sementara	Perawatan paliatif komprehensif jangka panjang

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN

Rumah sakit seyogyanya mempertimbangkan bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu system pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pemberi asuhan dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kontinuitas pelayanan. Maksud dan tujuan adalah menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelayanan yang sudah tersedia di rumah sakit, mengkoordinasikan pelayanan, kemudian merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya.

Sebagai hasilnya adalah meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit. Perlu informasi penting untuk membuat keputusan yang benar tentang :

1. Kebutuhan pasien yang dapat dilayani oleh rumah sakit;
2. Pemberian pelayanan yang efisien kepada pasien;
3. Rujukan ke pelayanan lain baik di dalam maupun keluar rumah sakit;
4. Pemulangan pasien yang tepat dan aman ke rumah

Skrining dapat terjadi di tempat pasien, ambulance, atau waktu pasien tiba di rumah sakit. Keputusan untuk mengobati, mengirim, atau merujuk dibuat setelah ada evaluasi hasil skrining. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanannya maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan.

5.1 Skrining Pasien

Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisis, psikologis, laboratorium klinis, atau *diagnostic imaging* sebelumnya. Skrining dapat terjadi di tempat pasien, ambulans, atau waktu pasien tiba di rumah sakit. Keputusan untuk mengobati, mengirim, atau merujuk dibuat setelah ada evaluasi hasil skrining. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi kemampuan pelayanannya maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan. Petugas instalasi gawat darurat harus dapat menyeleksi pasien sesuai dengan kondisi kegawatdaruratannya sebagai prioritas pertama pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pelayanan pasien gawat darurat yang berlaku dan tidak berdasarkan urutan kedatangan pasien untuk kemudian memilih pasien berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Ruang lingkup pelayanan pasien yang datang ke *instalasi gawat darurat* berdasarkan kondisi kegawatdaruratannya meliputi : Pasien dengan kasus *emergency*, yaitu pasien yang berada dalam kondisi sebagai berikut :

1. Pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat darurat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badanya (akan bisa menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan yang tepat dan secepatnya.
 2. Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan Tindakan darurat.
 3. Pasien akibat musibah/kejadian yang tiba-tiba terjadi, tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badanya.
- Skrining pasien dengan keterbatasan fisik :

Macam-macam / jenis-jenis kecacatan atau kelalaian pada manusia :

1. Buta (Tuna Netra)
Pasien buta adalah pasien yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Pasien yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada disekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah dari jarak tiga meter.
2. Tuli (Tuna Rungu)
Pasien tuli adalah pasien yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana pasien normal pada umumnya. Pasien yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.
3. Bisu (Tuna Wicara)

Pasien bisu adalah pasien yang tidak bisa berbicara dengan pasien lain. Pasien yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Pasien bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu Ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

4. Cacat Fisik (Tuna Daksa)

Pasien yang tuna daksa adalah pasien yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tanganya bunting, kakinya bunting, lumpuh, kakinya kecil sebetulnya, dan lain sebagainya.

5. Keterbelakangan mental (tuna grahita)

Pasien yang tuna grahita adalah pasien yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dibawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Cacat pengendalian diri (tuna laras)

Pasien tuna laras adalah pasien yang memiliki keterbatasan dalam pengendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu pasien yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

7. Cacat kombinasi (tuna ganda)

Pasien yang tuna ganda adalah pasien yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti pasien yang mengalami tangan bunting sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau pasien yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.

5.2 Triase

Pasien darurat, sangat mendesak, atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi menggunakan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan kebutuhan pasien yang mendesak dengan mendahulukan dari pasien lain dengan kurun waktu kurang dari 5 menit sudah dapat menentukan. Pada kondisi bencana dapat menggunakan triase bencana. Sesudah dinyatakan pasien darurat, mendesak, dan membutuhkan pertolongan segera maka dilakukan asesmen dan menerima pelayanan secepat-cepatnya. Kriteria psikologis dibutuhkan dalam proses triase. Pelatihan bagi staf diadakan agar staf mampu memutuskan pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan pelayanan yang dibutuhkan.

Pada waktu skrining dan pasien diputuskan diterima untuk rawat inap, proses asesmen membantu staf mengetahui prioritas kebutuhan pasien untuk pelayanan preventif, kuratif, rehabilitative, paliatif, dan dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan pasien. Pelayanan preventif (dalam proses admisi) adalah untuk mencegah perburukan / komplikasi, misalnya antara lain kasus luka tusuk dalam diberikan ATS dan kasus luka bakar derajat berat dimasukkan ke unit luka bakar.

Jika rumah sakit tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan kondisi darurat, pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang fasilitas pelayanannya dapat memenuhi kebutuhan pasien. Sebelumnya ditransfer atau dirujuk pasien harus dalam keadaan stabil dan dilengkapi dengan dokumentasi pencatatan.

Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kondisi mengancam nyawa. Tujuan triase selanjutnya adalah untuk menetapkan tingkat atau derajat kegawatan yang memerlukan pertolongan kedaruratan.

Dengan triase tenaga Kesehatan akan mampu :

1. Menginisiasi atau melakukan intervensi yang cepat dan tepat kepada pasien.
2. Menetapkan area yang paling tepat untuk dapat melaksanakan pengobatan lanjutan.
3. Memfasilitasi alur pasien melalui unit gawat darurat dalam proses penanggulangan/pengobatan gawat darurat.

Pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat diseleksi berdasarkan kondisi kegawat daruratannya dengan menggunakan *Australian Triase Scale* (ATS) sebagai

berikut :

1. ATS 1 adalah kondisi yang mengancam jiwa (atau resiko besar mengalami kemunduran) dan perlu intervensi yang cepat dan agresif.
2. ATS 2 adalah :
 - a. Pasien dengan kondisi yang cukup serius atau mengalami kemerosotan secara cepat yang apabila tidak ditangani dalam 10 menit dapat mengancam jiwa atau mengakibatkan kegagalan organ.
 - b. Pasien yang dengan pemberian obat yang dimana hasil akhirnya sangat tergantung dari seberapa cepat obat itu diterima oleh pasien (misalnya : trombolisis, antiracun).
3. ATS 3 adalah pasien yang datang dengan kondisi yang mungkin akan berkembang menjadi mengancam nyaman atau menimbulkan kecacatan bila tidak ditangani dalam waktu 30 menit.
4. ATS 4 adalah pasien dengan kondisi yang dapat mengalami kesemrosotan atau alam menghasilkan *outcome* yang berbeda bila dalam 1 jam pasien sebelum ditangani. Gejala berkepanjangan.
5. ATS 5 adalah kondisi pasien yang sudah kronis dengan gejala yang minor, dimana hasil akhirnya tidak akan berbeda bila penanganan ditunda sampe 2 jam setelah kedatangan.

Dengan Kombinasi dari PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KEGAWATDADURATAN

Pasein yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan Gawat Darurat dating dengan tingkat kegawatdaruratan yang berbeda (Prioritas 1 untuk yang benar benar Gawat Darurat atau true emergency, prioritas 2 yang gawat tetapi tidak darurat atau urgent , prioritas 3 yang tidak gawat maupun darurat atau false emergency) Semua pasien prioritas 1 tidak bisa menunggu dan butuh penanganan langsung (zero minute response).

Adapun berikut ini adalah berbagai kondisi yang dapat dikategorikan termasuk sebagai kasus

emergency, antara lain :

Prioritas 1 :

- ☐ Penurunan Kesadaran (V-P-U)
- ☐ Pulses
- ☐ Distress nafas
- ☐ Skala Nyeri lebih 7
- ☐ Menggunakan device oksigen
- ☐ Ada masalah di jalan nafas
- ☐ Danger Zone

Prioritas 2

- ☐ Kesadaran baik
- ☐ Skala nyeri 3-6
- ☐ Tensi 140/90 mmhg
- ☐ Setelah di lakukan pemeriksaan di lakukan pemeriksaan penunjang

Prioritas 3

- ☐ Kesadaran baik
- ☐ Skala Nyeri kurang 3
- ☐ Tanda tanda vital baik
- ☐ Tidak menggunakan pemeriksaan Penunjang
- ☐ Bisa periksa ke Poli Klinik

Untuk pasien anak-anak digunakan standar yang berbeda, karena kondisi pada anak jauh lebih berbahaya daripada dewasa.

Tabel 5.1 Triase anak <6 bulan

	RESIKO TINGGI	RESIKO SEDANG
Pemberian makanan	< ½ normal	½ - 2/3 normal
Arousal / tingkat kewaspadaan (SSP)	Sering mengantuk Penurunan aktivitas Konvulsi Tangisan lemah	Kadang mengantuk
Pernapasan	Apnea atau sianosis	Sesak napas
Sirkulasi	Kulit pucat dan panas	Kulit pucat
Output cairan	Muntah kehijauan <4x popok basah / hari	>5x muntah dalam 24 jam Kencing kurang dari biasanya
Feses	Tinja berdarah	

Proses triase dimulai ketika pasien masuk ke pintu IGD. Perawat triase harus mulai memperkenalkan diri, kemudian menanyakan riwayat singkat dan melakukan pengkajian, misalnya terlihat sekilas kearah pasien yang berada di brankar sebelum mengarahkan ke ruang perawatan yang tepat.

Pengumpulan data subjektif dan objektif harus dilakukan dengan cepat, tidak lebih dari 5 menit karena pengkajian ini tidak termasuk pengkajian perawat utama. Perawat triase bertanggung jawab untuk menempatkan pasien di area pengobatan yang tepat, misalnya bagian trauma dengan peralatan khusus, bagian jantung dengan monitor jantung dan tekanan darah, dll. Tanpa memikirkan dimana pasien pertama kali ditempatkan setelah triase, setiap pasien tersebut harus dikaji ulang oleh perawat utama sedikitnya sekali setiap 60 menit.

Untuk pasien yang dikategorikan sebagai pasien yang mendesak atau gawat darurat, pengkajian dilakukan setiap 15 menit/lebih bila perlu. Setiap pengkajian ulang harus didokumentasikan dalam rekam medis. Informasi baru dapat mengubah kategorisasi keakutan dan lokasi pasien di area pengobatan. Misalnya kebutuhan untuk memindahkan pasien yang awalnya berada di area pengobatan minor ke tempat tidur bermonitor ketika pasien tampak mual atau mengalami sesak napas, sinkope, atau diaphoresis (Iyer, 2004).

Bila kondisi pasien datang ketika datang sudah tampak tanda-tanda objektif bahwa ia mengalami gangguan pada *airway*, *breathing*, dan *circulation*, maka pasien ditangani terlebih dahulu. Pengkajian awal hanya didasarkan atas data objektif dan data subjektif sekunder dari pihak keluarga. Setelah keadaan pasien membaik, data pengkajian kemudian dilengkapi dengan data subjektif yang berasal langsung dari pasien (data primer).

Alur dalam proses triase :

1. Pasien datang diterima petugas atau paramedis IGD
2. Diruang triase dilakukan anamnesis dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya oleh perawat
3. Bila jumlah penderita / korban yang da lebih dari 50 orang, maka triase dapat dilakukan diluar ruang triase (diarea lorong IKO dan farmasi) dengan tambahan extra bad dan skeatsel
4. Setelah diseleksi, dilakukan Tindakan sebagai berikut,
 - a. Ditangani di tempat periksa / ditempat Tindakan sesuai

dengan kondisi klinisnya (bedah/non-bedah/obstetring inekologi)

- b. Jika didapatkan kegawat daruratan yang mengarah pada kondisi *cardiac arrest* dan / atau *respiratory arrest* segera ditangani di ruang resusitasi Prioritas 1
- c. Jika pasien yang datang termasuk Prioritas 2 dan Prioritas 3 datang pada jam kerja maka diarahkan ke instalasi rawat jalan untuk mendapatkan penanganan sesuai kondisi klinisnya dan bilamana perlu dianjurkan untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Jika pasien datang di luar jam kerja maka dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi klinisnya setelah kasus-kasus gawat darurat terlayani
- d. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia (*death on arrival*). Dipastikan terlebih dahulu bahwa pasien memang sudah meninggal dunia untuk kemudian bilamana perlu dibawa ke kamar jenazah.

Kategori	Waktu Respon Maksimum
Prioritas 1	Segera
Prioritas 2	30 menit
Prioritas 3	60 menit

5.3 Penundaan Pelayanan

Penundaan pelayanan adalah keadaan dimana pelayanan medis atau tindakan yang seharusnya diberikan kepada pasien tidak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan karena adanya hambatan tertentu.

Penundaan atau kelambatan pelayanan di IGD dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1. Faktor Sarana dan Prasarana
 - a. Keterbatasan ruang perawatan atau tempat tidur pasien
 - b. Kerusakan alat medis yang sedang digunakan
- 2. Faktor Eksternal
 - a. Lonjakan jumlah pasien secara tiba-tiba.
 - b. Keterbatasan fasilitas rujukan.

5.4 Pendaftaran IGD

Prosedur pendaftaran pasien IGD

- 1. Pasien Datang Sendiri atau Diantar Keluarga
 - a. Pasien datang ke IGD.
 - b. Perawat melakukan triase untuk menentukan tingkat kegawatdaruratan pasien.
 - c. Keluarga di arahkan untuk mendaftar.
 - d. Apabila pasien dalam kondisi gawat darurat, pasien langsung mendapatkan tindakan medis.
 - e. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien berdasarkan data yang diberikan pasien atau keluarga.
 - f. Petugas memeriksa apakah pasien sudah memiliki nomor rekam medis.
 - g. Jika pasien baru, petugas membuat nomor rekam medis baru.
 - h. Jika pasien lama, petugas mencari data rekam medis pasien.
 - i. Petugas melengkapi data administrasi pasien.
 - j. Data pasien dimasukkan ke dalam sistem informasi rumah sakit atau buku registrasi IGD.
- 2. Pasien Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Lain
 - a. Pasien datang dengan membawa surat rujukan.
 - b. Petugas triase melakukan penilaian kondisi pasien.
 - c. Pasien mendapatkan pelayanan medis sesuai kondisi kegawatdaruratan.
 - d. Keluarga diarahkan untuk mendaftar.
 - e. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien dan data rujukan.
 - f. Petugas menyimpan dokumen rujukan dalam berkas rekam medis pasien.
- 3. Pasien Tanpa Identitas (Mr./Mrs. X)

- a. Jika pasien datang tanpa identitas, petugas memberikan identitas sementara.
- b. Petugas mencatat ciri-ciri pasien yang dapat dikenali.
- c. Setelah identitas pasien diketahui, data pasien diperbarui dalam sistem rekam medis.

5.5 Penerimaan pasien IGD ke Rawat Inap

Penerimaan pasien dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) ke ruang rawat inap dilakukan melalui proses koordinasi antara tenaga medis, perawat, dan petugas administrasi untuk menjamin kesinambungan pelayanan pasien.

Proses penerimaan pasien IGD ke rawat inap meliputi:

1. **Penilaian Kondisi Pasien**
Dokter IGD melakukan pemeriksaan dan penilaian kondisi pasien. Apabila pasien memerlukan perawatan lanjutan yang tidak dapat ditangani secara rawat jalan, dokter menetapkan indikasi rawat inap.
2. **Konsultasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)**
Dokter IGD melakukan konsultasi dengan dokter spesialis atau dokter penanggung jawab pelayanan terkait untuk menentukan rencana perawatan pasien.
3. **Penentuan Ruang Perawatan**
Petugas IGD berkoordinasi dengan bagian pendaftaran atau admission untuk memastikan ketersediaan tempat tidur sesuai dengan kondisi medis pasien dan kelas perawatan.
4. **Penyelesaian Administrasi Rawat Inap**
5. **Persetujuan Rawat Inap**
Pasien atau keluarga diminta menandatangani persetujuan rawat inap serta dokumen persetujuan tindakan medis apabila diperlukan.
6. **Persiapan Transfer Pasien**
Perawat IGD menyiapkan pasien untuk dipindahkan ke ruang rawat inap, termasuk:
 - a. Melengkapi dokumen E- rekam medis
 - b. Melakukan stabilisasi kondisi pasien apabila diperlukan
7. **Serah Terima Pasien**
Perawat IGD melakukan serah terima pasien kepada perawat ruang rawat inap dengan menyampaikan:
 - a. Identitas pasien
 - b. Diagnosis sementara
 - c. Kondisi pasien terakhir
 - d. Terapi yang telah diberikan
 - e. Advice DPJP
8. **Pemindahan Pasien ke Ruang Rawat Inap**
Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap menggunakan sarana transportasi yang sesuai (kursi roda atau brankar) dengan pendampingan petugas kesehatan sesuai kondisi pasien.
9. **Asesmen Awal di Ruang Rawat Inap**
Setelah pasien tiba di ruang rawat inap, perawat dan dokter melakukan asesmen awal untuk melanjutkan rencana perawatan pasien

5.6 Tatalaksana *Informed Consent*

Tatalaksana *informed consent* merupakan proses pemberian informasi yang lengkap kepada pasien atau keluarga mengenai tindakan medis yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela.

Proses tatalaksana *informed consent* meliputi:

Dokter yang akan melakukan tindakan medis wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien atau keluarga mengenai:

- a. Diagnosis dan kondisi pasien
- b. Tujuan tindakan medis yang akan dilakukan
- c. Prosedur tindakan medis
- d. Manfaat tindakan
- e. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
- f. Alternatif tindakan lain beserta risikonya
- g. Prognosis penyakit

5.7 Pengelolaan Alur IGD

Unit darurat yang penuh sesak dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi dapat menyebabkan pasien menumpuk di daerah unit darurat dan menciptakannya sebagai tempat menunggu sementara pasien rawat inap. Mengelola alur berbagai pasien selama menjalani asuhannya masing-masing menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukannya yang selanjutnya mengganggu waktu pelayanan dan akhirnya juga berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen, dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien. Komponen dari pengelolaan alur pasien termasuk :

- a. Ketersediaan tempat tidur rawat inap
Ketersediaan tempat tidur rawat inap tersedia dilayar monitor yang ada di depan IGD rumah sakit prima husada meliputi :
 1. TT yang tersedia beserta kelas
 2. TT yang terpakai dan TT yang belum terpakai
- b. Perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien dapat disediakan dilorong irna lantai 1 dan lantai 2 gedung B, dimana dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut :
 1. Bed pasien
 2. Standart infus
 3. Oksigen transport
- c. Perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukkan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat dilakukan perbantuan tenaga yang disuplay dari unit atas persetujuan kepala ruang.
- d. Alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca anastesi).
- e. Efisiensi pelayanan non klinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi) dilakukan oleh petugas helper dengan prioritas membantu instalasi gawat darurat.
- f. Pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien diberikan berdasarkan prosedur yang diterapkan di rumah sakit prima husada antara lain :
Akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

Monitoring dan perbaikan proses ini merupakan strategi yang tepat dan bermanfaat untuk mengatasi masalah. Semua staf rumah sakit, mulai dari unit rawat inap, unit darurat, staf medis, keperawatan, administrasi, lingkungan, dan manajemen risiko dapat ikut berperan serta menyelesaikan masalah arus pasien ini. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh seorang Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/Case Manager.

Alur pasien menuju dan penempatannya di unit gawat darurat berpotensi membuat pasien bertumpuk. Ada penempatan pasien di unit gawat darurat yang merupakan jalan keluar sementara mengatasi penumpukan pasien rawat inap rumah sakit.

Dengan demikian, rumah sakit harus menetapkan standar waktu berapa lama pasien di unit darurat dan di unit intermediate, kemudian harus ditransfer ke unit rawat inap rumah sakit. Diharapkan rumah sakit dapat mengatur dan menyediakan yang aman bagi pasien.

5.8 Assasement Gawat Darurat

Asesmen yang efektif menghasilkan keputusan tentang tindakan segera dan berkelanjutan yang dibutuhkan pasien untuk Tindakan darurat, asuhan terencana, bahkan jika kondisi pasien berubah. Asesmen pasien merupakan proses berkelanjutan, dinamis dan dikerjakan di instalasi atau unit gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan unit pelayanan lainnya. Asesmen pasien terdiri dari 3 proses utama dengan metode IAR :

1. Mengumpulkan data dan informasi (huruf I) tentang hal-hal sesuai d s/d n, tersebut dibawah. Pada SOAP adalah S-

subyektif dan O-obyektif.

2. Analisis data dan informasi (huruf A), yaitu melakukan analisis terhadap informasi yang menghasilkan diagnosis, masalah dan kondisi untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Pada SOAP adalah A-Asesmen.
3. Membuat rencana huruf R, yaitu menyusun solusi untuk mengatasi atau memperbaiki kelainan Kesehatan sesuai butir b. pelaksanaan R adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien yang telah teridentifikasi. Pada SOAP adalah P-Plan.

Asesmen awal masing-masing pasien gawat darurat meliputi :

1. Status fisik
2. Psiko-sosio-spiritual
3. Ekonomi
4. Riwayat Kesehatan pasien
5. Riwayat alergi
6. Asesmen nyeri
7. Risiko jatuh
8. Asesmen fungsional
9. Risiko nutrisi
10. Kebutuhan edukasi
11. Perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*)

5.9 Rencana Asuhan

Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat kualitas asuhan yang sama di rumah sakit. Untuk melaksanakan prinsip kualitas asuhan yang setingkat mengharuskan pimpinan merencanakan prinsip dan mengordinasi pelayanan pasien. Secara khusus, pelayanan yang diberikan kepada populasi pasien yang sama pada berbagai unit kerja dipandu oleh yang menghasilkan pelayanan yang seragam. Sebagai tambahan, pimpinan harus menjamin bahwa rumah sakit menyediakan tingkat kualitas asuhan yang sama setiap hari dalam seminggu dan pada setiap shift tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membentuk proses pelayanan pasien dan dikembangkan secara kolaboratif.

Adapun pasien yang seragam terefleksi sebagai berikut :

1. Akses untuk asuhan dan pengobatan yang memadai dan diberikan oleh PPA yang kompeten tidak bergantung pada hari setiap minggu atau waktunya setiap hari.
2. Penggunaan alokasi sumber daya yang sama, antara lain staf klinis dan pemeriksaan diagnostik untuk memenuhi kebutuhan pasien pada populasi yang sama.
3. Pemberi asuhan yang diberikan kepada pasien, contoh pelayanan anastesi sama di semua unit pelayanan di rumah sakit.
4. Pasien dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang sama menerima asuhan keperawatan yang setara di seluruh rumah sakit.
5. Penerapan serta penggunaan dan form dalam bidang klinis antara lain metode asesmen IAR (Informasi, Analisis, Rencana), form asesmen awal, asesmen ulang, PPK, alur klinis terintegrasi/clinical pathway, pedoman manajemen nyeri, dan untuk berbagai tindakan antara lain water sealed drainage, pemberian transfusi darah, biopsi ginjal, pungsi lumbal, dsb.

Asuhan pasien seragam menghasilkan penggunaan sumberdaya secara efisien dan memungkinkan membuat evaluasi hasil asuhan (*outcome*) untuk asuhan yang sama di seluruh rumah sakit. Pada waktu skrining dna pasien diputuskan diterima untuk rawat inap, proses asesmen membantu staf mengetahui prioritas kebutuhan pasien untuk pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan pasien. Pelayanan preventif (dalam proses admisi) adalah untuk mencegah perburukan atau komplikasi, misalnya antara lain kasus luka tusuk dalam diberikan ATS dan kasus luka bakar derajat berat dimasukkan ke unit luka bakar.

5.10 Tatalaksana Sistem Rujukan

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialisik dan tindakan, serta penunjang diagnostik. Jika pasien dirujuk ke rumah sakit yang merujuk harus memastikan fasilitas kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas menerima pasien.

Diperoleh kepastian terlebih dahulu dan kesediaan menerima pasien serta persyaratan rujukan diuraikan dalam bekerja sama formal atau dalam bentuk perjanjian. Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi. Rujukan ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal :

1. Ada tentang rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rujukan pasien dilakukan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan asuhan pasien.
3. Rumah sakit yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk.
4. Ada kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima.

Tata laksana rujukan

1. Petugas penanggung jawab (staf pengelola rujukan) oleh dokter IGD
2. Perangkat kerja
 - a. Ambulan
 - b. Formulir persetujuan atau penolakan tindakan rujuk
 - c. Formulir rujukan
3. Tata laksana sistem rujukan IGD
 - a. Daftar rumah sakit dan dokter penyedia pelayanan kesehatan dilingkungan rumah sakit Prima Husada yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit dan populasi pasien rumah sakit Prima Husada
 - b. Rujukan keluar rumah sakit dapat ditujukan kepada individu secara spesifik dan darimana pasien berasal ;
 - 1) Alih rawat / rujuk
 - a) Dokter IGD sebagai menghubungi rumah sakit yang akan dirujuk
 - b) Dokter IGD memberikan informasi pada dokter jaga rumah sakit rujukan mengenai keadaan umum pasien
 - c) Dokter IGD memberikan edukasi kepada pasien
 - d) Bila pasien setuju, maka mengisi form persetujuan rujukan dan menandatangani form pemberian edukasi
 - e) Bila pasien tidak setuju, maka mengisi form penolakan rujukan, tanda tangan form pemberian edukasi dan membuat surat pernyataan
 - f) Bila tempat telah tersedia di rumah sakit rujukan, perawat IGD menghubungi driver ambulans RS Prima Husada sesuai kondisi pasien
 - g) Perawat melakukan serah terima kepada perawat penerima
 - 2) Pemeriksaan diagnostik
 - a) Pasien/keluarga pasien dijelaskan oleh dokter jaga mengenai rujukan pemeriksaan diagnostik, bila setuju maka keluarga pasien harus mengisi *informed consent*
 - b) Perawat IGD menghubungi rumah sakit rujukan
 - c) Perawat IGD menghubungi driver ambulans RS Prima Husada

- 3) Spesimen
 - a) Pasien/keluarga pasien dijelaskan mengenai rujukan pemeriksaan spesimen
 - b) Bila keluarga setuju maka harus mengisi *informed consent*
 - c) Dokter jaga mengisi formulir pemeriksaan, diserahkan kepetugas laboratorium
 - d) Petugas laboratorium melakukan rujukan ke laboratorium yang dituju

Tatalaksana Transportasi Pasien :

- 1) Permintaan ambulance transfer / rujuk H-1
 - a. Unit mengisi form permintaan ambulance
 - b. Form permintaan ambulance dibawa keluarga pasien ke kasir
 - c. Kasir menstempel tanda lunas di form permintaan ambulance memberikan ke keluarga pasien
 - d. Form permintaan ambulance diserahkan keluarga ke unit
 - e. Unit menyerahkan form permintaan ambulance ke pos 7b
 - f. Saat akan digunakan mengantar pasien, driver memberikan form ke IGD
- 2) Permintaan ambulance untuk transfer / rujuk cito
 - a. Unit mengisi form permintaan ambulance dan menghubungi bagian IGD permintaan ambulance
 - b. Petugas IGD menghubungi pengemudi ambulance yang sedang berjaga
 - c. Form permintaan ambulance dibawa keluarga pasien ke kasi
 - d. Kasir menstempel tanda lunas di form permintaan ambulance dan memberikan ke keluarga pasien
 - e. Form permintaan ambulance diserahkan keluarga ke unit
 - f. Unit konfirmasi pengemudi ambulance kalau semua sudah siap
 - g. Perawat mengantar pasien ke ambulance
 - h. Perawat IGD memberikan form permintaan ambulance, mencatat di buku permintaan ambulance dan mengambil peralatan ambulance
 - i. perawat mengingatkan keluarga untuk mengisi kuesioner
 - j. pengemudi memberikan kuesioner ke bagian pengelolaan pelanggan setelah kembali dari pengantaran
- 3) Persyaratan kendaraan transfer / rujuk
 - a) Teknis
 1. Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
 2. Ruangan pasien mudah mencapai dari tempat pengemudi
 3. Tempat duduk bagi petugas di ruang pasien
 4. Dilengkapi sabun pengaman
 5. Ruangan pasien cukup luas untuk sekurang-kurangnya dua stecher
 6. Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 cm diatas tempat pasien
 7. Stop kontak khusus untuk 220 volt DC diruang pasien
 8. Lampu ruangan secukupnya
 9. Lemari obat dan peralatan
 10. Sirine satu nada
 11. Lampu rotator warna merah, biru (biru masih dalam proses pelepasan)
 12. Persyaratan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
 13. Tanda pengenal ambulance transportasi dari bahan yang memantulkan sinar
 14. Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa indonesia
 - b) Medis

1. Tabung oksigen dengan peralatannya
2. Box emergency
3. Monitor
- c) Petugas
 1. Satu pengemudi dengan kemampuan P3K dan komunikatif
 2. Satu perawat dengan kemampuan PPGD
- d) Tata tertib
 1. Selama mengangkut pasien hanya boleh menggunakan lampu rotator (untuk pasien pulang / APS tanpa lampu rotator)
 2. Semua perlengkapan lalu lintas harus di taati
 3. Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
 4. Kecepatan kendaraan setinggi 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan
- 4) Persyaratan ambulance jenazah
 - a) Teknis
 1. Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
 2. Brangka dilengkapi sabuk pengaman
 3. Sirine satu atau dua nada
 4. Lampu rotator warna merah dan biru
 5. Ruang jenazah terpisah dari ruang pengemudi
 6. Tempat duduk atau duduk lipat minimal empat orang disamping jenazah
 7. Air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
 8. Tanda pengenal ambulance atau kereta jenazah dari bahan yang memantulkan sinar
 9. Persyaratan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
 - b) Petugas □ satu pengemudi yang komunikatif
 - c) Tata tertib
 1. Sirine hanya digunakan saat bergerak dalam iringan jenazah dan mematuhi peraturan lalu lintas tentang konvoi
 2. Apabila tidak dalam iringan hanya boleh menghidupkan lampu rotator
 3. Semua perlengkapan lalu lintas harus di taati
 4. Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
 5. Kecepatan kendaraan setinggi 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan

5.11 Tatalaksana Pasien Melarikan Diri

Tatacara penanganan pasien melarikan diri (pasien dianggap meninggalkan rumah sakit tanpa seizin dihitung $\pm$ 3jam sejak waktu pergantian petugas)

Tatalaksana :

Perawat segera melapor :

1. Ke keamanan secara tertulis pada buku khusus laporan keamanan dengan data pasti tentang pasien meliputi :
 - a. Nama
 - b. Alamat
 - c. Meninggalkan ruangan tanggal : Jam
 - d. Ciri-ciri khusus
2. Ke bagian kasi memberikan data perincian biaya pemakaian obat dan alkes, sewa alat, kwitansi dokter, pemeriksaan yang belum diperinci, konsultasi gizi dan lain-lain

3. Kepala ruang atau penanggungjawab ruangan melaporkan kejadian pasien melarikan diri melalui telepon disertai laporan tertulis kronologis kejadian pada
 - a. Dokter yang merawat atau dokter jaga
 - b. Kepala bidang keperawatan
 - c. Bag. Administrasi pasien dengan melampirkan data yang belum masuk :
 - 1) Pemakaian obat dan alkes habis pakai
 - 2) Jasa dokter
 - 3) Pemeriksaan penunjang
4. Keamanan atau satpam
 - a. Mencari alamat pasien yang bersangkutan
 - b. Membuat berita acara pasien kabur
 - c. Melaporkan berita acara kepada kepala keamanan dengan tembusan dan Subid Keperawatan

BAB VI LOGISTIK

Pengelolaan obat dan alat kesehatan / alkes meliputi pemesanan, pengambilan, penyimpanan dan pencatatan obat / alkes untuk pasien – pasien IGD.

Mekanisme pengadaan obat dan alat medis di IGD adalah sebagai berikut :

1. Persiapan alat
 - a. Lembaran *stock* obat
 - b. Buku keluar / masuk alat
 - c. Buku inventaris alat
 - d. Blangko pemesanan obat dan alkes
2. Setiap hari petugas / pekaya pagi menyeterilkan dan mengambil kembali setelah disterilkan untuk disimpan pada tempatnya.
3. Pemesanan alat kesehatan dilakukan oleh perawat penanggung jawab dinas pagi setiap hari dengan mengisi blanko pemesanan alkes yang ditandatangani Kepala perawat / Kepala IGD dengan jumlah yang sesuai pengeluaran / kebutuhan, kecuali bila jatuh pada hari libur, pemesanan dilakukan sehari sebelumnya.
4. Pengadaan alat umum :
 - a. Petugas IGD membuat permintaan ke bagian Pengadaan, dengan mengisi Formulir Pengambilan Barang yang ditandatangani oleh Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat atau Kepala Instalasi Gawat Darurat.
 - b. Formulir diserahkan ke Bagian Gudang.
5. Pengadaan alat – alat kesehatan :
 - a. Instalasi Gawat Darurat mengajukan permintaan barang dengan mengisi formulir permintaan barang. Formulir tersebut terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat untuk diketahui, dipertimbangkan dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Kepala Bidang Pelayanan Medik.
 - b. Permintaan barang yang telah disetujui oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik, selanjutnya diajukan kepada Bagian Pengadaan, untuk dipertimbangkan dan pengesahan.
 - c. Bagian pengadaan melakukan negoisasi penawaran harga untuk mendapat kesepakatan harga dengan pemasok.
 - d. Bagian pengadaan memberi perintah kepada bagian / petugas pembelian, untuk membeli barang – barang sesuai kebutuhan bagian yang meminta. Dalam hal kebutuhan barang – barang rutin yang telah dilakukan perjanjian kerjasama, maka pembelian dapat langsung di lakukan ke pemasoknya, setelah ada pengesahan dari Bagian Pengadaan.
 - e. Bagian / petugas pembelian melakukan transaksi atas pembelian barang – barang sesuai permintaan baik untuk barang – barang rutin atau barang – barang yang non *stock*.
 - f. Pemasok mengantar barang ke RS. Prima Husada sesuai pesanan dan barang tersebut diterima oleh bagian, Bagian Pengadaan memeriksa apakah barang – barang tersebut sesuai dengan pesanan baik jenis maupun jumlah pesanan.
 - g. Kemudian bagian gudang mendistribusikan barang kepada Instalasi Gawat Darurat.
 - h. Untuk pengambilan barang di gudang yang sudah diajukan, Petugas IGD melakukan prosedur pada permintaan alat – alat umum diatas.

BAB VII KESELAMATAN PASIEN

7.1 Pengertian

Keselamatan pasien (Patient Safety) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi :

1. Asesmen resiko
2. Identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien
3. Pelaporan dan analisis insiden
4. Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
5. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko

Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh :

1. Kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan
2. Tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil

7.2 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunkan kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan (KTD)

7.3 Standart Keselamatan Pasien

1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metoda-metoda peningkat kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
6. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

7.4 Jenis Keselamatan Pasien

a. *Adverse event*

Adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis karena tidak dapat dicegah.

b. KTD yang tidak dapat dicegah

Unpreventable Adverse Event : suatu KTD yang terjadi akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan mutakhir.

c. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)

Near Miss : adalah suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (*commission*) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (*omission*), yang dapat mencederai pasien, tapi cedera serius tidak terjadi.

d. Kesalahan Medis

Sentinel Event : adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius ; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diteima, seperti: operasi pada bagian tubuh yang salah.

Pemilihan kata "sentinel" terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (seperti, amputasi pada kaki yang salah) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.

7.5 Tata laksana

1. Memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien
2. Melaporkan pada dokter jaga IGD
3. Memberikan tindakan sesuai dengan instruksi dokter jaga
4. Mengobservasi keadaan umum pasien
5. Mendokumentasikan kejadian tersebut pada formulir "Pelaporan Insiden Keselamatan"

BAB VIII KESELAMATAN KERJA

- 8.1 Pengertian
Keselamatan kerja merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat kerja / aktifitas staf lebih aman. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan pribadi ataupun rumah sakit.
- 8.2 Tujuan
1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS Prima Husada
 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
 3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
 4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
- 8.3 Tatalaksana Keselamatan Staf
1. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi yaitu,
 - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi,
 - b. Menggunakan alat pelindung (sarung tangan, kacamata, sepatu boot/alas kaki tertutup, celemek, masker dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu : urin, darah, muntah, sekret, dll
 - c. Melakukan perasat yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, misalnya : memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll.
 - d. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum dan sesudah menangani pasien.
 2. Terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius
 3. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilisasi yaitu,
 - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin
 - b. Pencucian dengan sabun
 - c. Pengeringan
 4. Menggunakan baju kerja yang bersih
 5. Melakukan upaya-upaya yang tepat dalam menangani kasus :
 - a. HIV/AIDS (sesuai prinsip pencegahan infeksi)
 - b. Flu burung
 6. Kewaspadaan standar staf/petugas IGD dalam menghadapi penderita dengan dugaan flu burung adalah :
 - a. Cuci tangan
 - b. Hal ini dilakukan sebelum dan sesudah memeriksa penderita
 - c. Memakai masker N95 atau minimal masker badan
 - d. Menggunakan pelindung wajah/kacamata google (bila diperlukan)
 - e. Menggunakan apron / gaun pelindung
 - f. Menggunakan sarung tangan
 - g. Menggunakan pelindung kaki (sepatu boot)
 - h. Hepatitis B/C (sesuai prinsip pencegahan infeksi)
- 8.4 Prinsip Keselamatan Kerja
Prinsip utama prosedur Universal Precaution dalam kaitan keselamatan kerja adalah menjaga hygiene sanitasi individu, hygiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan.
Ketiga prinsip tersebut dikabarkan menjadi lima kegiatan pokok yaitu :
1. Cuci tangan guna mencegah infeksi silang
 2. Pemakaian alat pelindung diantaranya pemakaian sarung tangan guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksi lain

3. Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai
4. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan
5. Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan

BAB IX
PENGENDALIAN MUTU

Beberapa indikator mutu dalam pelayanan gawat darurat sebagai berikut :

1. *Angka Keterlambatan Pelayanan Pertama Gawat Darurat (KPPGD)*
Pelayanan Pertama Gawat Darurat dikatakan terlambat apabila pelayanan terhadap penderita gawat dan atau darurat yang dilayani dengan tindakan *Life Saving* oleh petugas gawat darurat lebih dari 5 menit.
Petugas gawat darurat adalah petugas yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat, yang telah dilatih PPGD.
Tindakan Darurat atau Life Saving adalah tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan jiwa manusia yang sedang terancam karena penyakit atau luka-luka yang dideritanya.

Rumus :

$$\text{KPPGD} = \frac{\text{Banyaknya penderita gawat darurat yang dilayani dalam 5 menit per bulan}}{\text{Total penderita gawat darurat pada bulan tersebut}} \times 100\%$$

Analisis harus dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali secara terus menerus. Yang harus disimpulkan dari analisis ini adalah kecenderungan (trend) dari keterlambatan pelayanan pertama gawat darurat.

2. *Angka Kematian (AK) di IGD*
Rumus :

$$\text{AK} = \frac{\text{Jumlah Kematian}}{\text{Jumlah Pasien IGD}} \times 100\%$$

Angka kematian ini harus dikumpulkan dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan angka kematian ini dari waktu ke waktu. Tidak dimasukkan didalam angka kematian dalam Deat on Arrival (DOA).

BAB X PENUTUP

Demikian buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat ini disusun. Kami mengajak semua pihak yang bekerja di RS Prima Husada untuk dapat bersama-sama membina dan mengembangkan sistem pelayanan di IGD. Semua petugas baik tenaga medis, paramedis, maupun non medis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan gawat darurat hendaknya selalu mentaati ketentuan yang telah digariskan didalam buku pedoman ini.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 9 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS

